

步长新脑心通胶囊治疗 60 例阳痿疗效观察

郑秀琴

(泰宁县医院)

陈昭海

(泰宁卫生防疫站皮肤性病科)

阳痿是临床上常见的性功能障碍。是指男子在有性欲之下阴茎不能勃起或虽勃起但不坚,勃起不能维持以致不能完成性交。

笔者从 1995 年以来采用咸阳步长制药有限公司生产的步长新脑心通胶囊治疗阳痿 60 例,疗效满意,现介绍如下。

1 一般资料 60 例均属门诊连续性接诊病人,原发性阳痿 12 例,继发性阳痿 48 例,其中最大年龄 56 岁,最小年龄 20 岁,20 岁~30 岁 26 例,31 岁~40 岁 30 例,41 岁~50 岁 3 例,51 岁以上 1 例。继发于泌尿系统感染者 10 例,前列腺炎者 22 例,精神创伤者 21 例,原因不明者 7 例。伴随症状,腰膝酸软 36 例,失眠多梦 23 例,头晕目眩 24 例,气短乏力 16 例,畏寒肢冷 16 例,梦遗 18 例;有性欲 10 例,无性欲 13 例,夜尿多 8 例;腰有发凉 15 例。

2 治疗方法 步长新脑心通口服,每日 3 次,每次 5 粒,1 个月为 1 个疗程。连服 2 个疗程。痊愈:阴茎可随意勃起,性交

成功率达 85% 以上,有性满意(足)感,自觉症状消失。有效:阴茎有随意勃起,性交成功率达 70% 左右以上,自觉症状明显减轻或消失。无效:阴茎不能勃起,自觉症状无变化。

3 治疗结果 本组 60 例中,痊愈 46 例占 77%,有效率 23%,有效病例中疗程最短者 45 d,最长者 78 d。

4 典型病案 江×,男,29 岁,已婚 4 年,干部。因阳痿 4 年于 1995 年 6 月 6 日初诊。2 年前结婚后即临房阴茎痿软,性交无能,终致离婚,半年后再婚仍阳痿,房事无能伴头晕目眩耳鸣、腰膝酸软,乏困无力,既往有手淫史。给予口服步长新脑心通胶囊药后第 5 天开始阴茎有勃起感,但不坚,连续口服 45 d 之后阴茎可随意勃起,房事满意,诸证消失,随访 2 年未复发,并已生育一女。

5 体会 步长新脑心通胶囊是一种中成药,主要成份地龙、血竭、赤芍、葛根、三七等 8 味,具益脑健神,活血化瘀、舒展筋络,止痛等功效,其疗效机理有待进一步探讨。

氟喹诺酮类药物相互作用

冯晓华

(福建省第二人民医院)

郑丽清

(福建医科大学附属协和医院)

氟喹诺酮类是近年迅速发展起来的一类合成抗菌药物,其抗菌谱广,抗菌活性强,组织体内浓度高,口服吸收完全,半衰期长,不良反应大都轻微,目前应用甚广,临床上常用的有诺氟沙星、依诺沙星、环丙沙星、氧氟沙星、诺美沙星、氟罗沙星、培氟沙星等。由于临床上与氟喹诺酮类联合用药的机会较多,因此有关的药物相互作用颇受关注。

1 与多价金属阳离子 氟喹诺酮类与 Al^{3+} 、 Mg^{2+} 、 Fe^{3+} 、 Ca^{2+} 、 Fe^{2+} 、 Zn^{2+} 等多价金属阳离子可发生相互作用,其机理是上述金属阳离子能与氟喹诺酮类的 4-酮氧基 3-羟基发生络合作用,从而减少氟喹诺酮类药的吸收及生物利用度,致使其抗菌治疗失败。因此,临床上应避免氟喹诺酮类与含镁、

钙、氧化物的抗酸剂如硫糖铝、硫酸亚铁、含锌的多种维生素等合用,如不能避免时,在应用含上述金属阳离子的药物之前 2 h 给予氟喹诺酮类,可使这一相互作用大为减轻,但上述措施对硫糖铝无效^[1]。

2 与非甾体类抗炎药 氟喹诺酮类与联苯丁酮酸合用可诱发惊厥,与布洛芬合用可诱发痉挛发作^[2]。因为能抑制 γ -氨基丁酸(GABA)与受体结合的药物可增加中枢神经系统的兴奋性导致惊厥,而氟喹诺酮类不但使 GABA 自神经末梢的释放减少,尚可竞争性抑制 GABA 与突触后受体的结合,这一作用与氟喹诺酮类的亲脂性及浓度有关,其亲脂性越小,竞争性抑制能力越大,浓度越高,抑制能力越强。为避免发生

不良反应,对既往有癫痫病史,急性脑血管病患者,不应合用上述药物,一旦发生惊厥,除立即停药,确保呼吸道畅通外,应给予巴比妥类镇静剂。

3 与茶碱 诺氟沙星、环丙沙星、依诺沙星、培氟沙星通过抑制肝脏细胞色素 P450 系统的同功酶,抑制茶碱的神经脱甲基化过程,从而使茶碱的清除率下降,这一相互作用的程度与氟喹诺酮类的剂量呈正相关。据报道,诺氟沙星及环丙沙星可使血浆茶碱浓度升高 1~2 倍,出现严重胃肠道及神经症状为特征的中毒反应。故合用应减少茶碱用量,并监测血浆茶碱浓度。

4 与西咪替丁 西咪替丁能抑制肝细胞色素 P450 系统参与的 I 相代谢反应,因此凡在肝脏代谢的氟喹诺酮类与之合用,均可使氟喹诺酮类的肾外清除率下降。如西咪替丁与培氟沙星合用,后者的肾外清除率下降 24%^[1],西咪替丁可使依诺沙星、氧氟沙星肾清除减少 5%~20%,清除半衰期延长 30%^[2]。西咪替丁抑制氟罗沙星肝脏代谢,使 AUC 增加($P < 0.05$), $T_{1/2}$ 延长至 15.5 h,总清除率下降($P < 0.05$)^[6]。

5 与某些抗生素 环丙沙星与氯霉素、强力霉素、氯洁霉素和大环内酯类抗生素合用时,除导致抗菌活性降低外,还可增加造血系统神经系统等不良反应^[5]。

6 与环胞素 器官移植时应用环胞素及氟喹诺酮类,少数病例发生可逆性肾功能不全,推测氟喹诺酮类可抑制环胞素的代谢,从而发生上述不良相互作用。

7 与华法令 已有数例报道,华法令与氟喹诺酮类合用,可使凝血时间延长,确切机制不清。因此两者合用应密切监测凝血时间,防止出血并发症。

8 与利福平 利福平可加速环丙沙星代谢,使其血药浓度大幅度下降^[3],导致治疗失败。

9 与苯妥英、卡马西平 环丙沙星具有酶促作用,与苯妥英、卡马西平合用可致后者代谢受阻,作用加强,同时肝毒性亦增加,导致苯妥英、卡马西平的中毒反应^[4]。

参考文献

1. 邓万俊:中国医院药学杂志 1993;13(10):450
2. 刘定勇等:国外医药抗生素分册 1990;11(1):57
3. 刘绪:中国医院药学杂志 1996;16(4):163
4. 郑晓淳等:中国抗生素杂志 1992;17(2):133
5. 赵玉芬:药事情报通讯 1994;12(2):30
6. 吴荣才等:中国医院药学杂志 1996;16(6):284

血管紧张素转换酶抑制药与其它心血管药物的相互作用

吴樟树

(永安市立医院)

血管紧张素转换酶抑制药(ACEI)能竞争性地抑制血管紧张素转换酶,减少血管紧张素Ⅱ的生成,从而使血管扩张,醛固酮分泌减少,抑制交感递质释放,逆转心血管重构等作用,还具有抗心肌缺血与保护心肌等作用,常用于高血压,充血性心力衰竭、慢性心功能不全,心肌梗塞、动脉粥样硬化等疾病的治疗。本文主要简介该类药物与其它心血管药合用治疗上述疾病时的相互作用。

1 与利尿药合用 ACEI 与利尿药合用可加强降压效果。由于 ACEI 具有减少醛固酮分泌的作用,产生保钾排钠的作用,合用时宜与排钾利尿药合用,不宜与保钾性利尿药合用,以避免高血钾的发生。

2 与 β -受体阻断药合用 两类药物可合用,增效作用不明显,相互间没有直接相互作用。

3 与钙通道阻滞剂合用 两类药物合用为合理配伍,可明显增效,减少不良反应,提高病人的耐受性,常与二氢吡啶类合用治疗高血压病。两类药物合用时应适当减量。

4 与地高辛合用 与地高辛合用治疗充血性心力衰竭有协

同作用,由于 ACEI 抑制地高辛的排泄,使地高辛血药浓度升高 1.5 倍左右,合用时应注意地高辛的用量。

5 与硝酸酯类药物合用 ACEI 与硝酸酯类药物合用治疗心绞痛有协同作用,由于合用后扩血管作用增强,应注意低血压的发生。姚峰、张秀芝^[1]研究认为消心痛长期服用疗效降低,联用卡托普利其抗心绞痛及抗心肌缺血作用明显增加,且远期疗效优于近期疗效。

6 与血管扩张药合用 血管扩张药除硝普钠还有扩张静脉外,大多是通过直接扩张小动脉平滑肌产生降压作用,这类药物降压作用快而强,可反射性兴奋交感神经,兴奋肾素-血管紧张素-醛固酮系统,从而减弱其扩张血管作用。血管扩张药与 ACEI 合用可增强扩张血管作用,在高血压、充血性心力衰竭的治疗中发挥协同的作用。

参考文献

1. 姚峰等:临床心血管病杂志 1995;11(3):182